Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde

PONTOS IMPORTANTES

- O Apoio Matricial é uma estratégia fundamental para promover a integralidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS).
- Facilita a colaboração interdisciplinar entre as equipes de Saúde da Família (SF) e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Atua nas dimensões técnico-pedagógica e assistencial, fortalecendo a capacidade resolutiva das equipes.
- Sua implementação requer coordenação eficaz, educação continuada e superação de desafios como a falta de conhecimento e estigmas.
- Possui potencial de expansão através da integração intersetorial, uso de tecnologias e abordagem culturalmente sensível.

Estratégias para a Implementação Efetiva do Apoio Matricial

Realização de reuniões regulares entre NASF e equipes de SF para alinhamento de estratégias e revisão de protocolos.

Promoção de consultas conjuntas e visitas domiciliares coordenadas para ampliar o acesso e a continuidade do cuidado.

Investimento em educação continuada e programas de capacitação para profissionais, visando familiarização com as práticas de matriciamento.

Na prática, o Apoio Matricial se materializa por meio de consultas conjuntas e visitas domiciliares coordenadas. Essas práticas ampliam o acesso aos cuidados e melhoram a continuidade do atendimento, permitindo que as equipes de SF e os especialistas do NASF trabalhem em conjunto para atender às necessidades dos pacientes de maneira mais holística e integrada [5]. A educação continuada e a formação dos profissionais são igualmente fundamentais para o sucesso do Apoio Matricial. Programas de capacitação auxiliam os profissionais a se familiarizarem com as práticas de matriciamento e a desenvolverem as competências necessárias para implementar eficazmente as estratégias de cuidado, sendo essencial em áreas onde há lacunas de conhecimento sobre o matriciamento [6].

No entanto, a implementação do Apoio Matricial enfrenta desafios significativos. A falta de conhecimento adequado sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais de saúde pode prejudicar a aplicação das práticas e ferramentas propostas, resultando em uma implementação ineficaz. Isso inclui a ausência de participação ativa dos profissionais e o estigma associado às condições de saúde, que pode impactar a adesão ao modelo [6]. Além disso, dificuldades relacionais e organizacionais são comuns, com problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática enfraquecendo a integração entre os serviços. Um estudo qualitativo que objetivou analisar as concepções sobre matriciamento em saúde mental [2] corrobora essas observações.

A frase "(Trata-se de um estudo qualitativo, que objetivou analisar as concepções sobre matriciamento em saúde mental[2])" foi integrada ao parágrafo anterior para maior fluidez.

Desafios na Implementação do Apoio Matricial

Lacunas de Conhecimento: A falta de compreensão sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais pode comprometer a eficácia da implementação.

Dificuldades Relacionais e Organizacionais: Problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática enfraquecem a integração dos serviços.

Estigma: O estigma associado a certas condições de saúde pode afetar a adesão ao modelo de matriciamento.

Formação Acadêmica Inadequada: A carência de uma base sólida em práticas de matriciamento na formação profissional limita a aplicação efetiva das estratégias.

A formação acadêmica inadequada dos profissionais constitui outro desafio identificado. A ausência de uma base sólida em práticas de matriciamento pode limitar a capacidade dos profissionais de aplicar efetivamente as estratégias propostas. A educação permanente é essencial para superar essas barreiras e aprimorar a compreensão e a eficácia das práticas matriciais [6]. Adicionalmente, um estudo realizado em Itapevi, SP, revelou dificuldades específicas nas ações de saúde na Atenção Básica, tais como a baixa capacidade de identificar demandas e riscos, a tendência à medicalização e a baixa participação dos usuários. Apesar dessas dificuldades, foram alcançados avanços significativos na percepção dos trabalhadores e na mobilização de recursos internos para o cuidado, servindo como base para a introdução do matriciamento [7].

Operacionalização do Apoio Matricial

Na prática, o Apoio Matricial se materializa por meio de consultas conjuntas, visitas domiciliares coordenadas, grupos terapêuticos e outras intervenções que respondem de forma abrangente às demandas variadas de saúde [5]. Essas práticas não apenas ampliam o acesso aos cuidados, mas também aprimoram a continuidade do atendimento, garantindo uma resposta mais efetiva às necessidades específicas dos usuários, especialmente aqueles com condições crônicas e complexas.

Um estudo analisou as práticas e concepções do matriciamento em saúde mental a partir das perspectivas de equipes de referência, equipes matriciais e gestores. Foram realizadas entrevistas com 41 participantes e observações de 110 horas das práticas matriciais. O estudo revelou duas principais concepções sobre o matriciamento: como uma oportunidade de encontro produtivo entre equipes de saúde e como uma estratégia de formação em serviço. As observações confirmaram a necessidade de criar, sistematizar e fortalecer espaços de diálogo entre equipes de referência, equipes matriciais e gestores para consolidar o matriciamento e aprimorar suas práticas [8].

Potenciais e Perspectivas Futuras

Para o futuro, o Apoio Matricial pode expandir-se por meio da integração intersetorial com serviços sociais, educacionais e comunitários [9]. Esta integração é crucial para fortalecer as redes de cuidado, permitindo uma abordagem mais holística dos determinantes sociais da saúde. A colaboração com esses setores pode não apenas melhorar o acesso e a qualidade dos serviços, mas também promover ações preventivas e educativas que são fundamentais para a saúde comunitária.

Além disso, a implementação de tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode otimizar a gestão de casos e facilitar o compartilhamento de informações entre as equipes de Saúde da Família e os serviços especializados. As TICs possuem o potencial de aprimorar a coordenação dos cuidados, apoiar a educação continuada dos profissionais de saúde e garantir que informações cruciais estejam acessíveis para todos os envolvidos no cuidado. Essas inovações tecnológicas podem contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada dos cuidados, elevando a qualidade dos serviços prestados.

Um exemplo relevante dessa abordagem é a proposta de intervenção desenvolvida na Região de Saúde de Cruz das Almas. Esta proposta visa melhorar a articulação entre as Equipes de Saúde da Família (ESF) e os serviços existentes, por meio da criação e implementação de uma matriz de intervenção adaptada às necessidades locais. O objetivo é promover espaços para a promoção e prevenção em saúde, além de oferecer um cuidado integrado na Atenção Básica. A proposta inclui a realização de encontros de avaliação e adequação para garantir que a implementação seja eficaz e atenda às necessidades da comunidade local [10].

Adicionalmente, uma perspectiva valiosa sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na Atenção Primária pode ser exposta ao se tratar de matriciamento. Um estudo qualitativo, desenvolvido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do Rio Grande do Sul, destaca a necessidade urgente de investimentos e suporte para melhorar as ações de promoção da saúde e prevenção. O artigo identifica o matriciamento como uma potencialidade para fortalecer a atuação da Atenção Primária, sugerindo que um maior investimento na formação e no suporte das equipes pode ter um impacto significativo na qualidade e eficácia dos cuidados oferecidos na Atenção Básica [11].

Além disso, um estudo qualitativo realizado na Região Sul do Brasil revelou que, apesar dos esforços para melhorar o cuidado, ainda há um descompasso entre as intenções dos apoiadores e as expectativas dos profissionais de saúde. Este conflito aponta para a necessidade de reavaliação das práticas e políticas públicas para garantir que o Apoio Matricial possa efetivamente promover a saúde e a cidadania na Atenção Primária à Saúde [12].

Por fim, é crucial incorporar uma perspectiva culturalmente sensível no planejamento e na prática do Apoio Matricial. Embora os profissionais reconheçam a importância dos condicionantes socioculturais nos casos clínicos e nas interações com usuários e comunidades, a competência cultural ainda é insuficiente para uma compreensão crítica da diversidade cultural. Estimular o debate sobre as dimensões socioculturais e considerar as particularidades culturais pode representar um avanço significativo no cuidado colaborativo, ajudando a superar desafios e potencializando as práticas matriciais. Assim, integrar a cultura no planejamento e na prática pode melhorar a adesão e a eficácia das intervenções em saúde [8].

O último parágrafo da seção "Potenciais e Perspectivas Futuras" continha uma repetição literal da ideia e da citação [8] dentro de parênteses. A redundância foi eliminada e a informação consolidada em um único parágrafo para maior concisão e fluidez.

Conclusão

O Apoio Matricial representa uma evolução significativa na forma como a APS aborda as complexidades de saúde da população. Ao integrar saberes e práticas, esta estratégia não apenas fortalece a capacidade de resposta das equipes de SF e NASF, mas também promove uma abordagem mais humanizada e centrada no paciente. A colaboração interdisciplinar, baseada em evidências e centrada no paciente, é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde pública, garantindo cuidados mais integrados e eficazes.

Links para Atualização:

1. *Ministério da Saúde - Atenção Primária à Saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/atencao-primaria-a-saude*

2. *Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC): https://www.sbmfc.org.br/*

3. *Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) - Atenção Primária à Saúde: https://www.paho.org/pt/topicos/atencao-primaria-saude*

REFERÊNCIAS

1 Como o apoio matricial pode ser desenvolvido na Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária em Saúde? Biblioteca Virtual em Saúde, 2015. Disponível em: < Acesso em: 14 ago. 2024. https://aps-repo.bvs.br/aps/como-o-apoio-matricial-pode-ser-desenvolvido-na-atencao-basica-em-saudeatencao-primaria-em-saude/>.

2 IGLESIAS, Alexandra. Conhecendo o matriciamento em saúde mental pela perspectiva dos matriciadores. Espaç.saúde, v. 22, 2021, pp. 1-12, 24. Disponível em: < https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353631>.

3 GUSMÃO, Ricardo. Atuação do enfermeiro em saúde mental na estratégia de saúde da família. Journal of Health and Biological Sciences, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: < https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v10i1.3721.p1-6.2022>.

4 SOUSA, Paulo Henrique Caetano de. Relato da implantação do matriciamento em um município cearense: dos desafios às conquistas. Rev. baiana saúde pública, v. 45, n. 4, pp. 241-251, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n4.a3422>.

5 COHEN, Marina Chansky. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface (Botucatu, Online), v. 25, e200462, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/Interface.200462>.

6 VASCONCELO, Marilena Silva de. Conhecimento de gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial sobre matriciamento em saúde mental. Ciênc. cuid. saúde, v. 18, n. 4, e43922, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v18i4.43922 >.

7 YAMAGUTI, Claudiney Augusto. Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), v. 20, n. 1, pp. 132-138, 2019. Disponível em: < https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1009105>.

8 IGLESIAS, Alexandra. Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de referência, matriciadores e gestores. Ciência & Saúde Coletiva (online), v. 24, n. 4, pp. 1247-1254, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.05362017>.

9 SANTOS, Angela Maria. O matriciamento em saúde mental como dispositivo para a formação e gestão do cuidado em saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva (online), v. 30, n. 04, e300409, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300409>.

10 SANTANA, Elisangela Ferreira de. Proposta de Matriciamento em Saúde Mental nos municípios da Região de Saúde de Cruz das Almas. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola Estadual de Saúde Pública, Salvador, 2019. Disponível em: < https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129712>.

11 SANTOS, Elitiele Ortiz dos. Avaliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na rede psicossocial. Escola Anna Nery (online), v. 27, e20220110, 2023. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0110pt>.

12 OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde: estudo fenomenológico. Acta Paulista de Enfermagem (online), v. 32, n. 6, pp. 674-682, 2019. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/1982-0194201900093>.

13 FAGUNDES, Giselle Soares. Matriciamento em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, pp. 2311-2322, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>.